PANORAMA
Saúde Suplementar

Rio de Janeiro - v.8 – nº 10 | dezembro 2025 – 3º trimestre 2025



ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

© 2025 ANS. Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial - Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. O conteúdo desta e de outras obras da Agência Nacional de Saúde Suplementar pode ser acessado na página: http://www.ans.gov.br/biblioteca/index.html

Versão online

ELABORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÕES:
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
ANS Diretoria de Gestão – DIGES
Gerência de Comunicação Social – GCOMS/SECEX/PRESI
Av. Augusto Severo, 84 – Glória
CEP 20021-040 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Tel: +55 (21) 2105-0000
Disque-ANS: 0800 701 9656
www.gov.br/ans

DIRETORIA COLEGIADA – DICOL
Diretor-Presidente e Diretor de Desenvolvimento Setorial – DIDES
Wadih Nemer Damous Filho
Diretora de Gestão Interina - DIGES
Carla de Figueiredo Soares
Diretora de Fiscalização – DIFIS
Eliane Aparecida de Castro Medeiros
Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE
Jorge Antônio Aquino Lopes
Diretora de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO
Lenise Barcellos de Mello Secchin

EQUIPE TÉCNICA:
Adriana Bion; Alexandre Fiori; Ana Cecília Faveret; Angela De Marchi; Angela Lugão; Carla Grilo; Carlos Gustavo Lopes; Carolina Hilal; Cátia Mantini; Cláudia Akemi Ramos Tanaka; Daniel Sasson; Fabio Matsumoto; Felipe Riani; Fernanda de Castro Souza; Flávia Marques; Flavia Tanaka; Flavia Souza; Flávio Alcoforado; Frederico Yasuo Noritomi; Gislaine Afonso de Souza; Graziela Scalercio; Isabella Eckstein; Iola Vasconcelos Robson Faria; Jacqueline Torres; Juliana Machado; Lalucha Silva; Leonardo Fernandes Ferreira; Luiz Vieira; Marcio Nunes de Paula; Maria Rachel Jasmim; Maria Tereza Pasinato; Mariana de Souza; Marluce Cristina Iotte de Almeida Chrispim; Marly Corrêa Peixoto; Mirella Amorim; Nina Zander; Pedro Villela; Renata de Campos Lopes da Silva; Rosana Neves; Sanya Franco Ruela; Sonia Marinho; Sophia Fukayama; Vanessa Maria Gomes de Carvalho; Washington Oliveira Alves

PROJETO GRÁFICO:
Gerência de Comunicação Social (GCOMS/SECEX/PRESI)

NORMALIZAÇÃO:
Sergio Pinheiro Rodrigues (CGDOP/GEQIN/DIGES)

Ficha Catalográfica

A265b Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil).
Boletim panorama: saúde suplementar. v.8 n. 10, 3º trimestre de 2025. 10 ed. Rio de Janeiro: ANS, 2025.
2Mb; ePub.
1.Saúde suplementar. 2.Dados em saúde. 3.Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). 3. Diretoria de Desenvolvimento Setorial. I. Título.

CDD 302.23

Catalogação na fonte – Biblioteca ANS

CARTA DO PRESIDENTE

Caros(as) leitores(as),

As transformações que atravessam o setor de saúde suplementar exigem maturidade regulatória, capacidade de diálogo e um compromisso permanente com a qualidade assistencial. Ao assumir a presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reafirmei meu compromisso de ampliar e aprimorar a regulação, promovendo um ambiente sustentável para todos os atores do sistema.

Meu objetivo, ao final dos próximos cinco anos, é consolidar uma Agência aberta à sociedade, mais eficiente na mediação entre beneficiários, prestadores e operadoras e assertiva na defesa do interesse público. Para isso, nos próximos anos, vamos incentivar a participação ativa da sociedade na construção da Agenda Regulatória, por meio de instrumentos como consultas e audiências públicas. Acreditamos que, assim, a regulação será de fato aderente às necessidades reais da população.

Nesse contexto, a Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES), da qual sou diretor, desempenha papel estratégico na indução de melhorias que beneficiam toda a sociedade. A implementação do Programa Agora Tem Especialistas ganha centralidade, pois representa um avanço inédito ao fortalecer a integração entre os sistemas público e privado. Pela primeira vez na história do país, dívidas tributárias ou valores de ressarcimento ao SUS podem ser convertidos diretamente em atendimentos especializados, reduzindo filas e garantindo cuidado oportuno a milhões de brasileiros que não possuem planos de saúde.

A DIDES também tem papel essencial na produção de informações setoriais, por meio de publicações como o Panorama da Saúde Suplementar, da abertura de bases de dados e da manutenção de painéis dinâmicos que permitem acompanhar a evolução do setor. Esses instrumentos apresentam dados e informações confiáveis e transparentes, proporcionando o empoderamento dos beneficiários e demais atores do setor.

Estamos trabalhando com firmeza, diálogo e compromisso público para que a saúde suplementar seja cada vez mais justa, eficiente e orientada ao cidadão. A ANS está preparada para liderar este novo momento, que exige coragem, responsabilidade e visão de futuro.

Wadih Damous

APRESENTAÇÃO

O Panorama da Saúde Suplementar destaca um dos principais avanços na integração entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Saúde Suplementar em 2025: o Programa Agora Tem Especialistas. A edição de dezembro detalha a iniciativa, criada para ampliar o acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados, reduzindo filas e tempos de espera em todo o país.

A publicação mostra que, nesse novo contexto, o componente Ressarcimento ao SUS assume papel estratégico ao permitir que operadoras de planos de saúde convertam dívidas em serviços prestados diretamente ao SUS, por meio de termos de compromisso firmados com gestores municipais e estaduais. Com isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforça sua atuação no acompanhamento da execução desses serviços e na avaliação dos impactos sobre os beneficiários das operadoras participantes.

A edição apresenta ainda os resultados do terceiro trimestre de 2025 e dados de beneficiários até outubro. O destaque é o crescimento dos planos exclusivamente odontológicos, que avançaram 2,88% em um ano, além da expansão de 2,70% nos planos médico-hospitalares — impulsionados exclusivamente pelas contratações coletivas empresariais.

O relatório traz também informações atualizadas sobre a taxa de rotatividade do setor e sobre a utilização de serviços de saúde. Apesar de avanços em exames e atendimentos ambulatoriais, a maioria dos procedimentos permanece abaixo dos níveis registrados antes da pandemia. No Ressarcimento ao SUS, até setembro, foram registradas cobranças de R$ 1,05 bilhão, com R$ 703 milhões efetivamente repassados ao Fundo Nacional de Saúde.

No campo econômico-financeiro, o setor segue em trajetória positiva: o resultado líquido acumulado atingiu R$ 14 bilhões nos últimos quatro trimestres, marcando oito períodos consecutivos de crescimento. Já na área de relações com consumidores, a publicação destaca as ações fiscalizatórias orientadas pela regulação responsiva e os resultados das Ações de Fiscalização Planejada (AFPs) realizadas entre 2023 e 2025.

Outro ponto que reforça o contínuo aperfeiçoamento da regulação é a publicação de 18 novos normativos entre junho e novembro, sendo oito deles relacionados à incorporação de 11 novas tecnologias ao Rol de Procedimentos. A edição também evidencia o compromisso da Agência com a participação social: no período analisado foram realizadas seis audiências públicas, nove consultas públicas e duas alterações no marco legal — entre elas, a promulgação da Lei nº 15.233/2025, que oficializou o Programa Agora Tem Especialistas.

Com dados inéditos, análises de mercado e os principais destaques regulatórios do período, a nova edição do Panorama da Saúde Suplementar registra um momento de transformação para o setor.

Boa leitura!

SUMÁRIO

1 GRANDES NÚMEROS DO SETOR _____ 6

2 BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE _____ 7

3 ASSISTÊNCIA À SAÚDE _____ 9

4 CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO _____ 19

5 INFORMAÇÕES DE DEMANDAS DO CONSUMIDOR __ 22

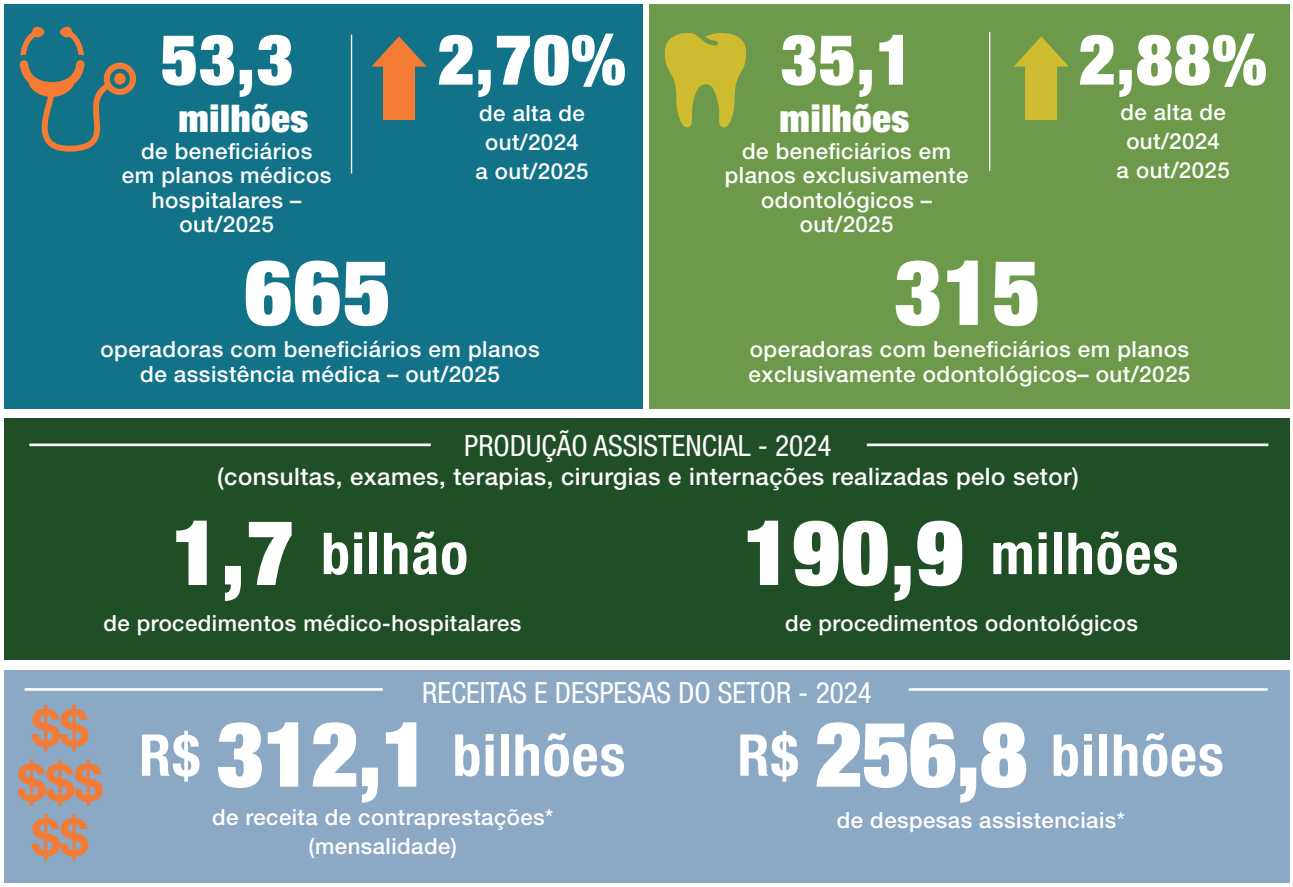
6 PROGRAMAS E PROJETOS DA ANS _____ 27

7 ASPECTOS NORMATIVOS E LEGAIS _____ 29

1 GRANDES NÚMEROS DO SETOR

Os grandes números do setor são apresentados na figura 1, a seguir, trazendo um compilado de informações de diversos sistemas de informações da ANS, de acordo com as últimas atualizações disponíveis. A quantidade de vínculos de beneficiários e operadoras, por tipo de assistência – médico-hospitalar ou odontológica, referem-se ao mês de outubro de 2025. Já a variação percentual de beneficiários refere-se ao período de 1 ano (out/2024 a out/2025). O total de procedimentos, oriundos do SIP – Sistema de Informações de Produtos, referem-se ao ano de 2024. Apresenta-se também o total em Reais de receitas de contraprestações e despesas assistenciais em 2024.

Figura 1: Grandes Números do Setor de Saúde Suplementar



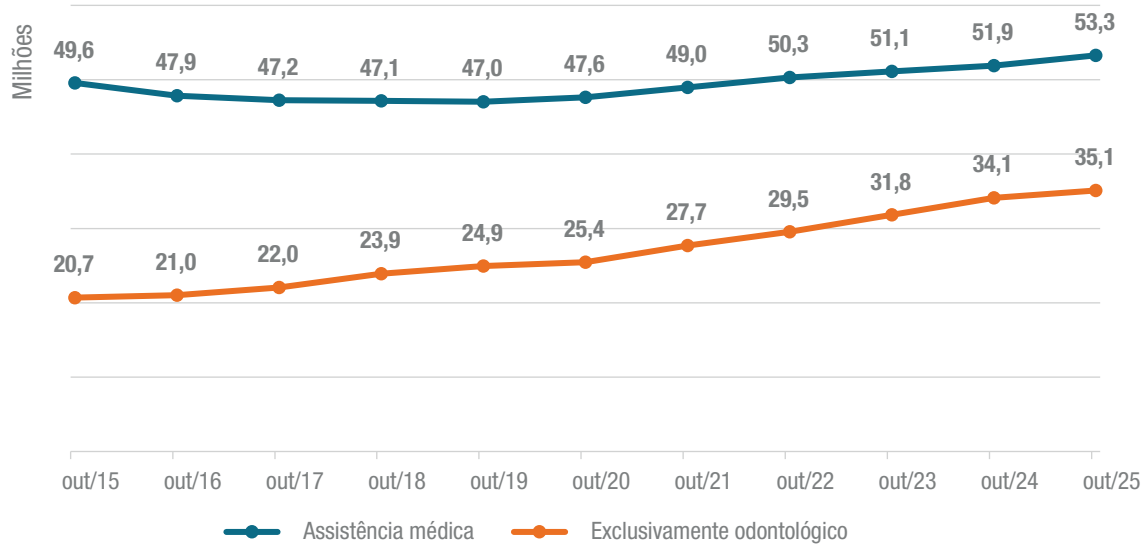
Fonte: ANS/MS (diversos sistemas)
*Nota: A partir do 4º trim. de 2024 não foram incluídos no painel de Dados Econômico-Financeiros da Saúde Suplementar os dados de entidades reguladas que celebraram Termo de Compromisso (TC) com a ANS que envolva prazos para regularização contábil. A Receita de Contraprestações refere-se a contraprestações efetivas.

2 BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE

Em outubro de 2025, o número de vínculos de beneficiários a planos de assistência médica chegou a 53.277.390, 2,70% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Os planos exclusivamente odontológicos tinham 35.104.258 vínculos de beneficiários, correspondendo a um aumento de 2,88% em relação ao ano anterior.

O gráfico 1 apresenta a evolução do número de beneficiários nos últimos 10 anos, entre outubro de 2015 e outubro de 2025.

Gráfico 1 - Beneficiários de planos de saúde por cobertura assistencial Brasil - outubro/2015-outubro/2025



Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2025

O crescimento do número de beneficiários em planos de assistência médica foi apenas em planos coletivos empresariais (4,35%). Vale observar que a variação do número de beneficiários nos demais tipos de contratação tem sido negativa nos últimos anos. Entre os meses de outubro de 2024 e de 2025, os planos individuais tiveram uma diminuição de 2,02% no número de beneficiários e os planos coletivos por adesão 0,75%.

Em relação aos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, é importante destacar que as variações foram fortemente impactadas pelas movimentações de uma única operadora que informou a inclusão de mais de 1,6 milhões de vínculos em planos individuais entre 2023 e 2024 e o cancelamento de igual número entre 2024 e 2025.

Para efeito de avaliação do crescimento do setor, quando excluídos os dados desta operadora do cálculo, resulta que o crescimento do número de beneficiários em planos odontológicos, entre outubro de 2024 e outubro de 2025, foi de 6,31%.

Taxa de rotatividade

A movimentação de entrada e saída de beneficiários nas operadoras é acompanhada pela ANS por meio da taxa de rotatividade[1], que é calculada com dados de adesões e cancelamentos de vínculos ao longo de um período determinado.

Em 2024, foram informadas 16.366.896 adesões e 15.638.015 cancelamentos em planos de assistência médica, resultado em uma taxa de rotatividade de 30,5%, ou seja, quase um terço dos vínculos foram substituídos ao longo do ano.

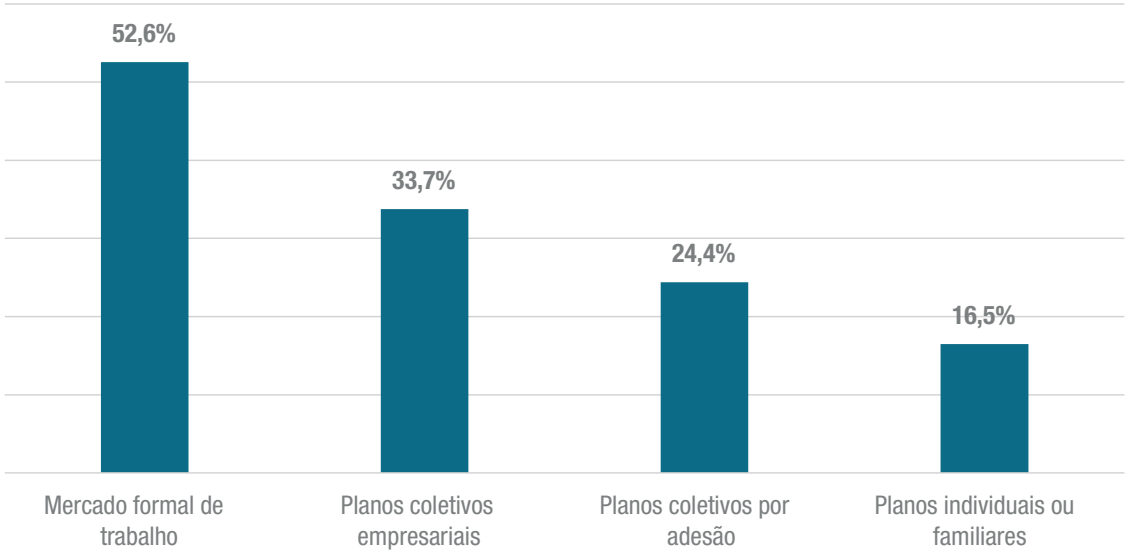
A taxa contribui para a compreensão de diversos aspectos relativos ao mercado da saúde suplementar, tais como concorrência, qualidade da atenção à saúde, rede, serviço da operadora e oferta de programas de promoção e prevenção.

Alguns aspectos devem ser considerados na análise deste indicador:

- A taxa de rotatividade tem se mantido estável nos últimos anos, (32,2% em 2021, 29,5% em 2022, 29,1% em 2024 e 30,5% em 2025).
- A taxa de rotatividade é diferenciada segundo os tipos de contratação do plano. Nos planos individuais a taxa, em 2024, foi de 16,5%, nos planos coletivos por adesão 24,4% e nos coletivos empresariais 33,7%. Estes dados estão ilustrados no gráfico 2, abaixo.
- O número de beneficiários de planos coletivos empresariais representava, em dezembro de 2024, 71,9% do total de beneficiários ativos. Os cancelamentos foram 78,2% do total e as adesões 81,9%.
- Em 2024, quase 8,5 milhões de cancelamentos foram motivados por desligamento do beneficiário da empresa contratante. Este número representa 69,1% dos cancelamentos em planos coletivos empresariais.
- A taxa de rotatividade no mercado formal de trabalho é mais elevada que na saúde suplementar. O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que acompanha as admissões e demissões no mercado formal de trabalho, registrou em 2024, 25.607.844 admissões e 23.929.376, resultando em uma taxa de rotatividade de 52,6% (gráfico 2).

1 Cálculo da taxa de rotatividade: o menor valor entre o número de adesões e de cancelamentos em 2024, dividido pelo número de beneficiários em dezembro de 2023 (representando o número de beneficiários no início de 2024).

Gráfico 2 – Taxa de rotatividade no mercado formal de trabalho e nos planos de assistência médica
Brasil - 2024



Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2025 e MTE/Painel de Informações do Novo CAGED - 09/2025

3 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

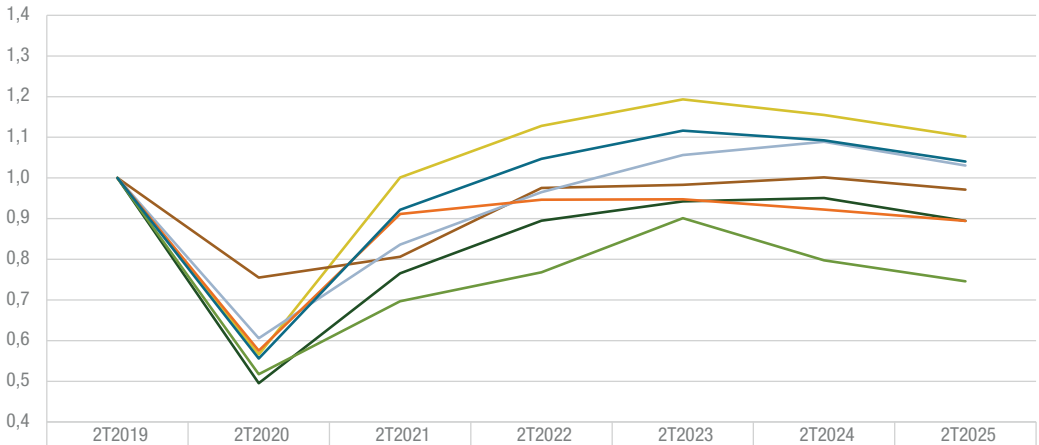
Frequência de utilização de serviços de saúde

O conjunto de indicadores a seguir tem por objetivo apresentar a evolução da utilização de serviços de saúde a partir de 2019, com base na relação de eventos por beneficiário (número de procedimentos realizados por pessoa), de forma a considerar o efeito do crescimento da base de beneficiários no período.

O gráfico 3 apresenta a utilização de serviços de saúde no 2º trimestre entre os anos de 2019 e 2025, por grupo de procedimentos, tendo por base o ano de 2019.

No segundo trimestre de 2025, a utilização dos serviços de saúde caiu em todos os grupos de procedimentos. Quando comparamos com o mesmo período de 2019 – usado como referência por representar o padrão antes da pandemia de Covid-19 – apenas os grupos de “Exames” e “Outros atendimentos ambulatoriais” registraram uma utilização maior. Para os demais tipos de procedimentos, o número de atendimentos por pessoa ainda continua abaixo do que era observado em 2019.

Gráfico 3 - Índice de variação da frequência de utilização assistencial por beneficiário (base 1, 2º trimestre de 2019)

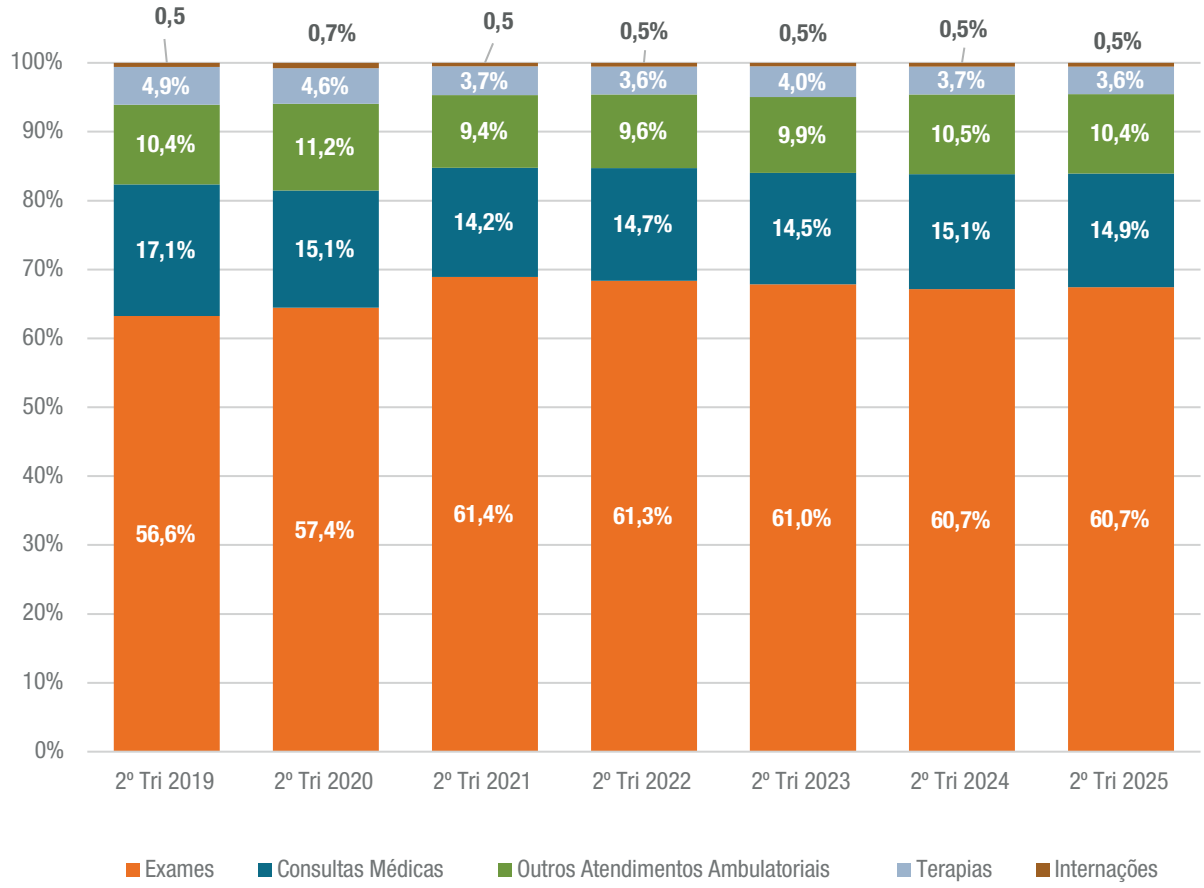


	2T2019	2T2020	2T2021	2T2022	2T2023	2T2024	2T2025
Consultas Médicas	1,00	0,50	0,77	0,89	0,94	0,95	0,89
Exames	1,00	0,57	1,00	1,13	1,19	1,15	1,10
Internações	1,00	0,75	0,81	0,98	0,98	1,00	0,97
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1,00	0,61	0,84	0,97	1,06	1,09	1,03
Procedimentos Odontológicos	1,00	0,58	0,91	0,95	0,95	0,92	0,89
Terapias	1,00	0,52	0,70	0,77	0,90	0,80	0,75
Total MH	1,00	0,56	0,92	1,05	1,12	1,09	1,04

Fonte: SIP/ANS (dados de 2019 a 2022: extração em 02/07/2023; dados de 2023: extração em 13/05/2025; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração em 09/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração em 02/11/2025) e SIB/ANS (dados de 2019 a 2023: extração da base do SIB em 09/05/2024; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 10/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 06/11/2025).

O gráfico 4 apresenta a composição da produção assistencial médico-hospitalar do setor, por grupo assistencial, no segundo trimestre de cada ano entre 2019 e 2025. De modo geral a distribuição por grupo assistencial vem se mantendo estável desde 2019. Considerando o histórico do 2º trimestre de cada ano, os exames têm representado cerca de 60% dos eventos médico-hospitalares do setor. Já as internações são responsáveis por cerca de 0,5% dos atendimentos realizados.

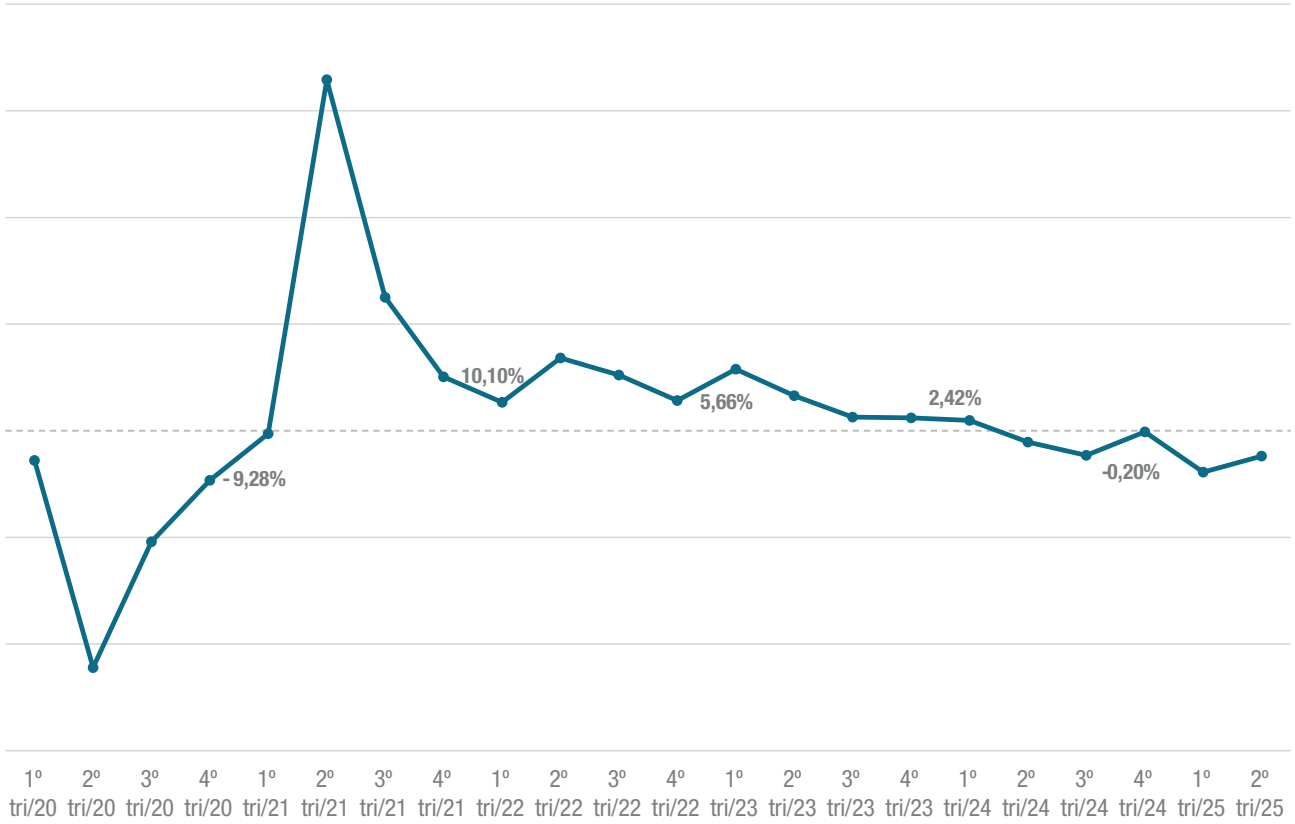
Gráfico 4 - Distribuição (%) da Produção Assistencial Médico-Hospitalar por Grupo de Eventos (2019/2025)



Fonte: SIP/ANS (dados de 2019 a 2022: extração em 02/07/2023; dados de 2023: extração em 13/05/2025; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração em 09/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração em 02/11/2025).

O gráfico 5 apresenta a variação na utilização dos serviços de assistência médico-hospitalar por beneficiário, com a comparação de cada trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao longo de 2024, observou-se uma trajetória de redução no uso desses serviços. No entanto, no quarto trimestre de 2024, houve uma leve reversão dessa tendência, com um pequeno aumento na utilização. No primeiro e segundo trimestres de 2025, a tendência de queda em relação aos mesmos trimestres do ano anterior foi retomada.

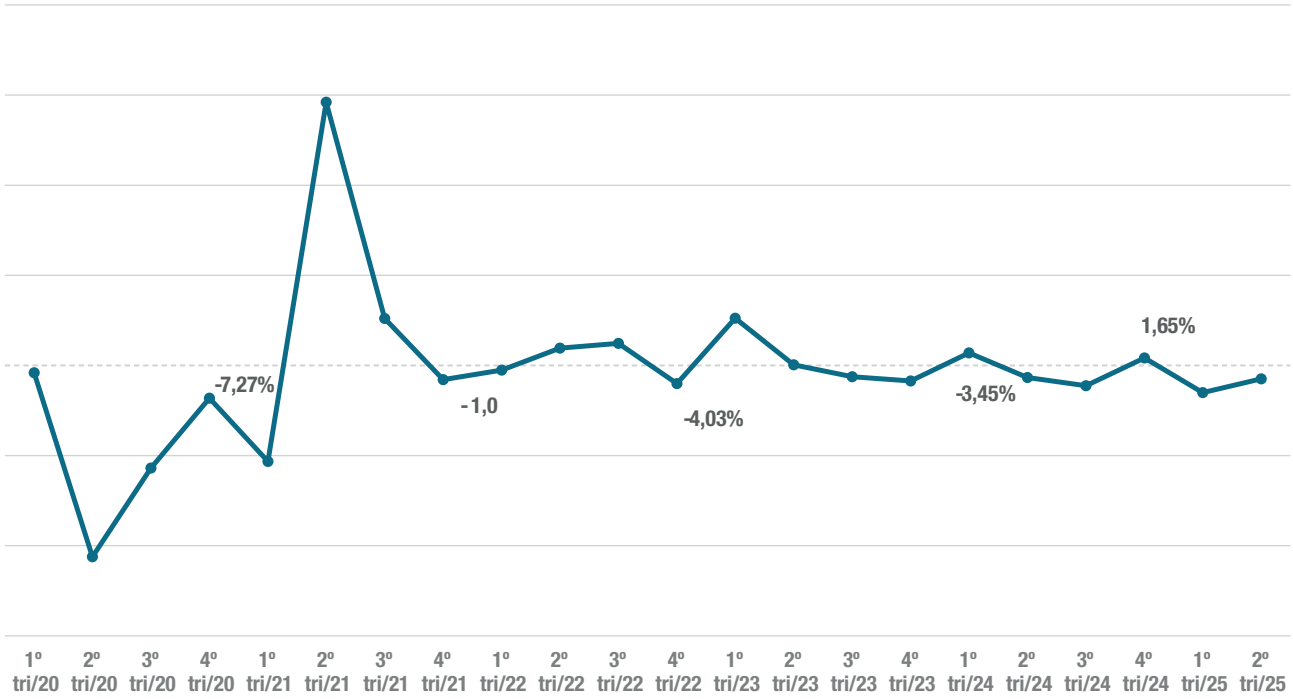
Gráfico 5 - Variação (%) do total de eventos médico-hospitalares por beneficiário em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



Fonte: SIP/ANS (dados de 2019 a 2022: extração em 02/07/2023; dados de 2023: extração em 13/05/2025; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração em 09/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração em 02/11/2025) e SIB/ANS (dados de 2019 a 2023: extração da base do SIB em 09/05/2024; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 10/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 06/11/2025).
* Total de eventos de assistência médico-hospitalar informados pelas operadoras ao SIP considerando-se a soma dos grupos assistenciais (A. CONSULTAS MÉDICAS + B. OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS + C. EXAMES + D. TERAPIAS + E. INTERNAÇÕES), sobre o total de beneficiários da assistência médico-hospitalar informados ao SIB pelas operadoras.

A mesma comparação é apresentada no gráfico 6 para os procedimentos odontológicos. A série apresenta estabilidade desde 2023, com pequenas flutuações ao longo do período.

Gráfico 6 - Variação (%) do total dos procedimentos odontológicos por beneficiário em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

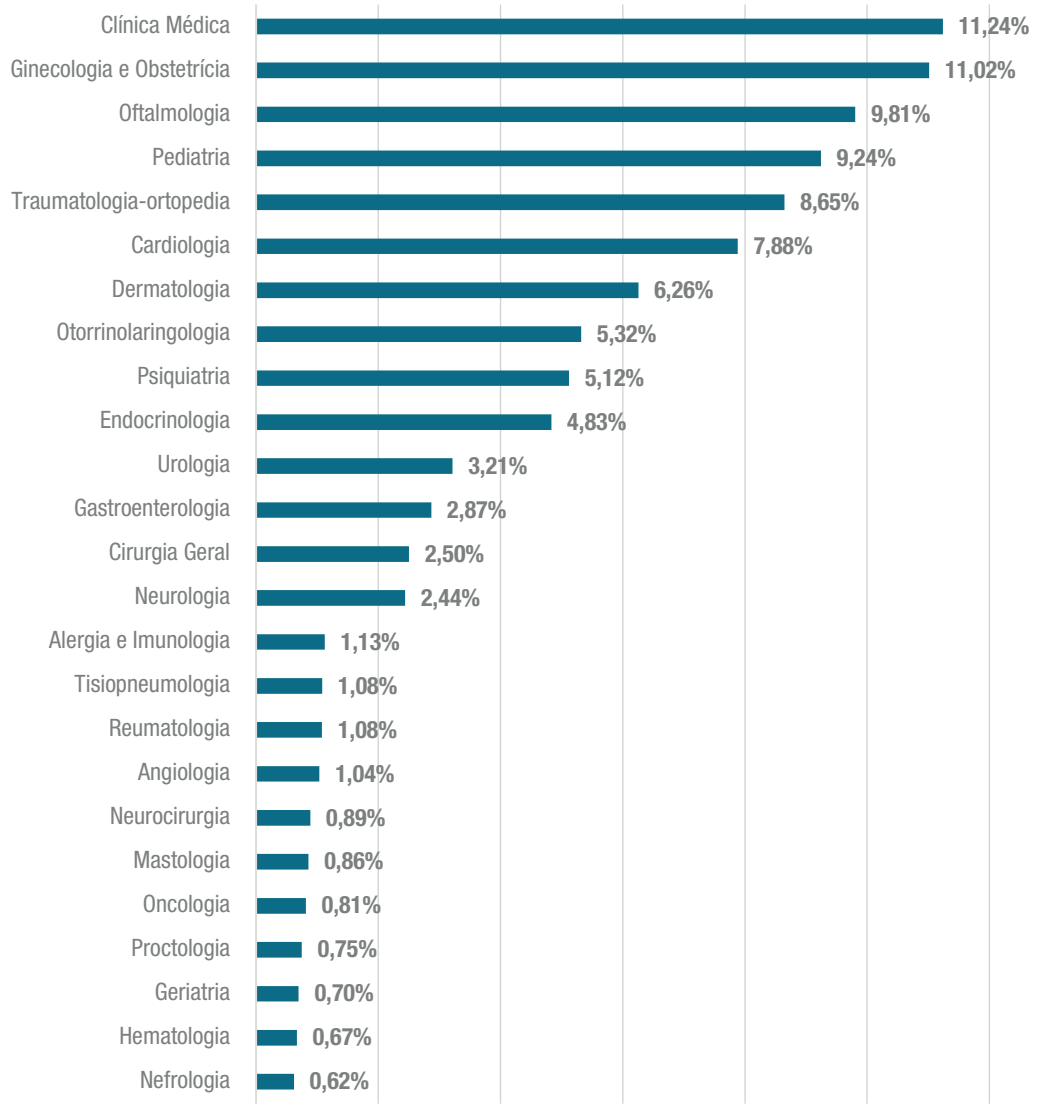


Fonte: SIP/ANS (dados de 2019 a 2022: extração em 02/07/2023; dados de 2023: extração em 13/05/2025; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração em 09/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração em 02/11/2025) e SIB/ANS (dados de 2019 a 2023: extração da base do SIB em 09/05/2024; dados de 2024 e 1ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 10/06/2025; dados do 2ºtrim/2025: extração da Sala de Situação em 06/11/2025).

Em 30/05/2025 foi lançado pelo Ministério da Saúde o Programa Agora Tem Especialistas, que tem por objetivo garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada, abrangendo consultas, exames, cirurgias, tratamentos oncológicos e demais atendimentos especializados da rede pública. No componente ambulatorial do Programa, atualmente estão contempladas as seguintes especialidades: cardiologia, ginecologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e otorrinolaringologia.

O gráfico 7 mostra a distribuição das consultas por especialidade, considerando somente as consultas médicas ambulatoriais com especialidade informada ao SIP. Para traçar um paralelo com a saúde suplementar, estão sublinhadas em vermelho as especialidades contempladas pelo Programa Agora Tem Especialistas. Observamos que, no que tange às consultas médicas ambulatoriais, das especialidades destacadas no SIP, as mais consultadas na saúde suplementar no 2º trimestre de 2025 englobam as especialidades selecionadas pelo Programa. Ressalta-se que a oncologia não está entre as especialidades mais frequentes em termos de quantidade de consultas médicas, o que é esperado devido à natureza e à prevalência do câncer. Contudo, sua inclusão é de extrema importância para fins de prevenção, diagnóstico e o devido tratamento em tempo hábil.

Gráfico 7 – Distribuição das consultas médicas ambulatoriais segundo a especialidade informada ao SIP – 2º trimestre de 2025



Fonte: SIP/ANS (dados do 2ºtrim/2025: extração em 02/11/2025)

Vale lembrar que esses dados estão sujeitos a alterações pelas operadoras, de forma que os resultados aqui apresentados para o 2º trimestre de 2025 se baseiam nos dados enviados pelas operadoras ao SIP até a data de coleta (02/11/2025).

Variação de valores de despesas médias de eventos assistenciais

O indicador a seguir tem por objetivo apresentar a variação das despesas médias de alguns eventos assistenciais selecionados - Consulta Médica, Serviços Profissionais / Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SP/SADT), Internações, e Procedimentos Odontológicos. Os dados foram extraídos do banco de dados do Padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar). Essa edição do Panorama, atualizada em relação a última publicação, avalia comparativamente dados acumulados até o 3º trimestre dos anos 2019 a 2025.

O gráfico 8, a seguir, indica a variação das despesas médias por eventos selecionados.

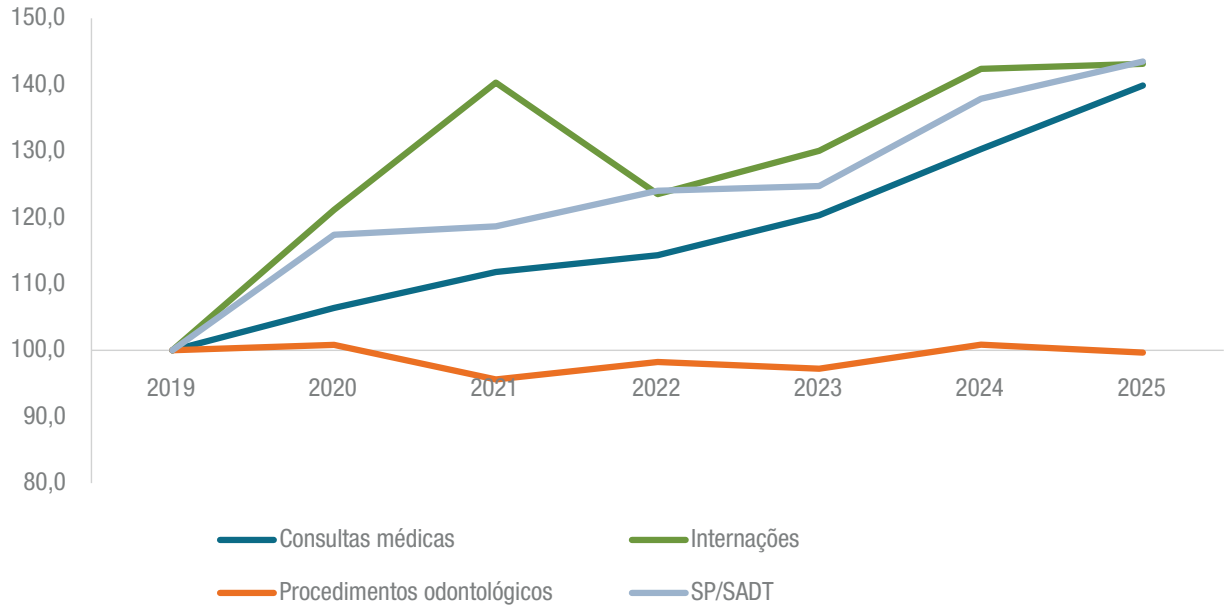
É possível observar a variação positiva das despesas médias para internações, ano-base 2019, atingindo um pico em 2021, coincidindo com o período da Pandemia da Covid-19, e das medidas de distanciamento social.

As despesas relativas às consultas médicas (39,9%%) e aos Serviços Profissionais e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SP/SADT) (43,5%) foram crescentes ao longo de quase todo o período.

As despesas médias com internações, que voltaram a acompanhar o crescimento dos grupos mencionados acima, apresentaram um discreto crescimento nos três primeiros trimestres de 2025, com uma variação acumulada de 43,1% em relação ao mesmo período de 2019.

As despesas médias relativas aos atendimentos odontológicos, ao contrário, se mantiveram muito próximas dos níveis de 2019, com uma pequena redução, em 2025 (-0,3%).

Gráfico 8 - Variação de despesa média por evento ou procedimento Brasil, 1º ao 3º trimestre/2019 - 1º ao 3º trimestre/2025

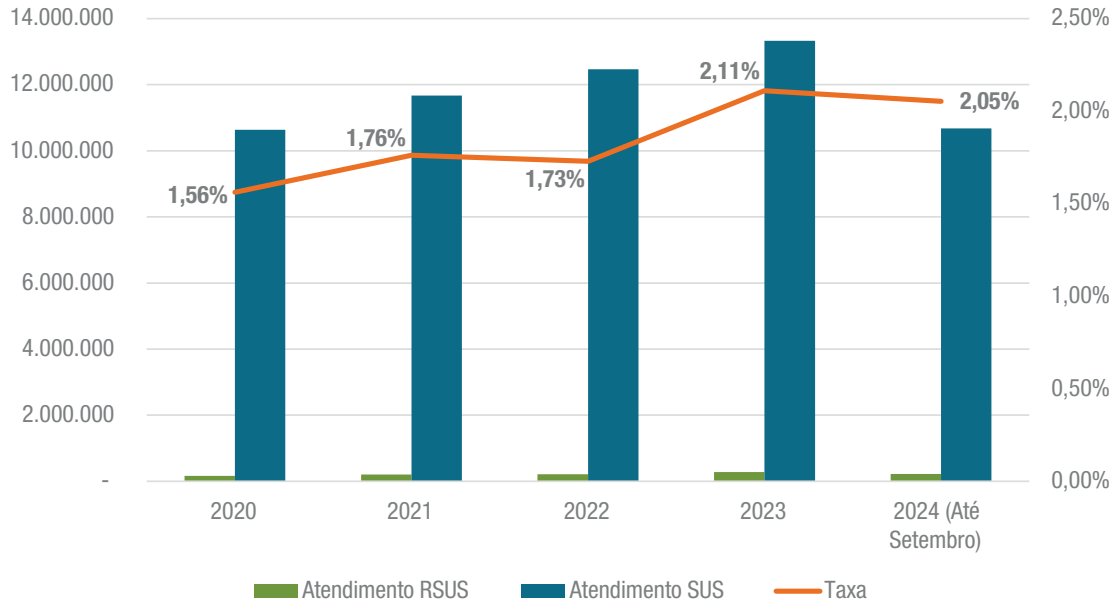


Fonte: TISS/ANS (setembro/2025)
Nota: 1º ao 3º trimestre/2019 = 100

Utilização da rede SUS por beneficiários

Nos últimos cinco anos, das cerca de 12 milhões de internações anuais no âmbito do Sistema único de Saúde SUS e registradas em Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), cerca de 1,7% ocorreram em pacientes cobertos por planos privados de saúde com assistência médica. Já as internações ocorridas no SUS no ano de 2024, até o mês de setembro, notificadas pela ANS às operadoras no ano de 2025, representaram mais de 2,05% do total do SUS. (gráfico 9).

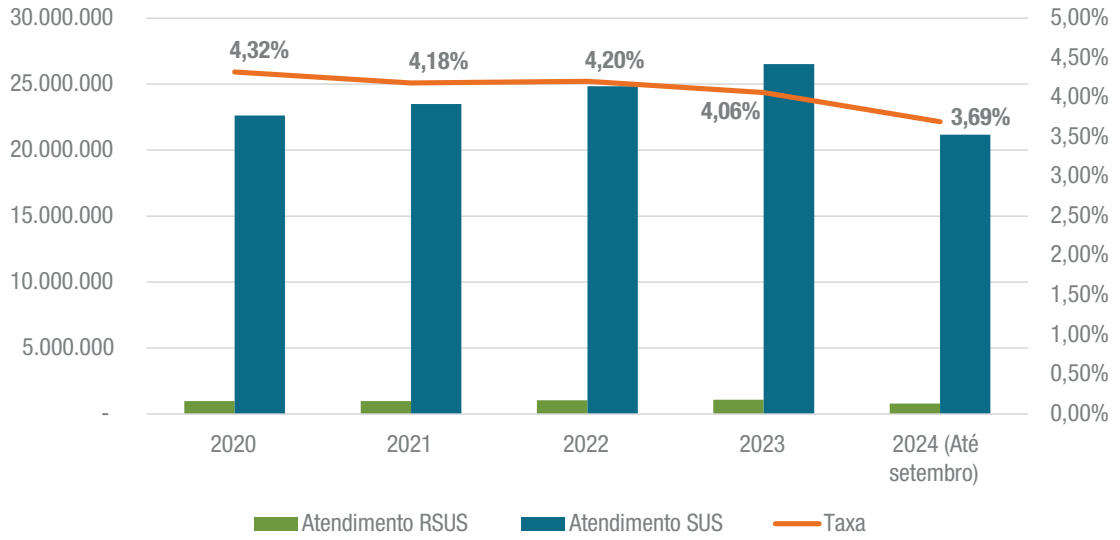
Gráfico 9 - Internações registradas em AIH ocorridas no SUS em beneficiários de planos de saúde – atendimentos de 2020 a setembro de 2024.



Fonte: MS/Datasus e ANS/SGR (novembro/2025).
Nota: O gráfico exibe o ano dos atendimentos ocorridos no SUS, cuja notificação no âmbito do Ressarcimento ao SUS ocorre cerca de 1 ano depois. Resultados passíveis de atualização.

Em relação aos atendimentos ambulatoriais registrados por meio de Autorizações de Procedimento Ambulatorial de Média e Alta Complexidade (APAC), registrou-se em média 26,2 milhões de procedimentos anuais no SUS, dos quais 4,3% identificados foram prestados a beneficiários de planos de saúde. Para atendimentos ocorridos no SUS no ano de 2023 e notificados pela ANS às operadoras em 2024, identificou-se parcela de atendimentos a beneficiários que alcançaram 4,06% em relação ao total realizado no SUS. Considerando-se os casos ocorridos até setembro de 2024 e notificados pela ANS às operadoras até setembro de 2025, este percentual ficou em 3,69% (gráfico 10).

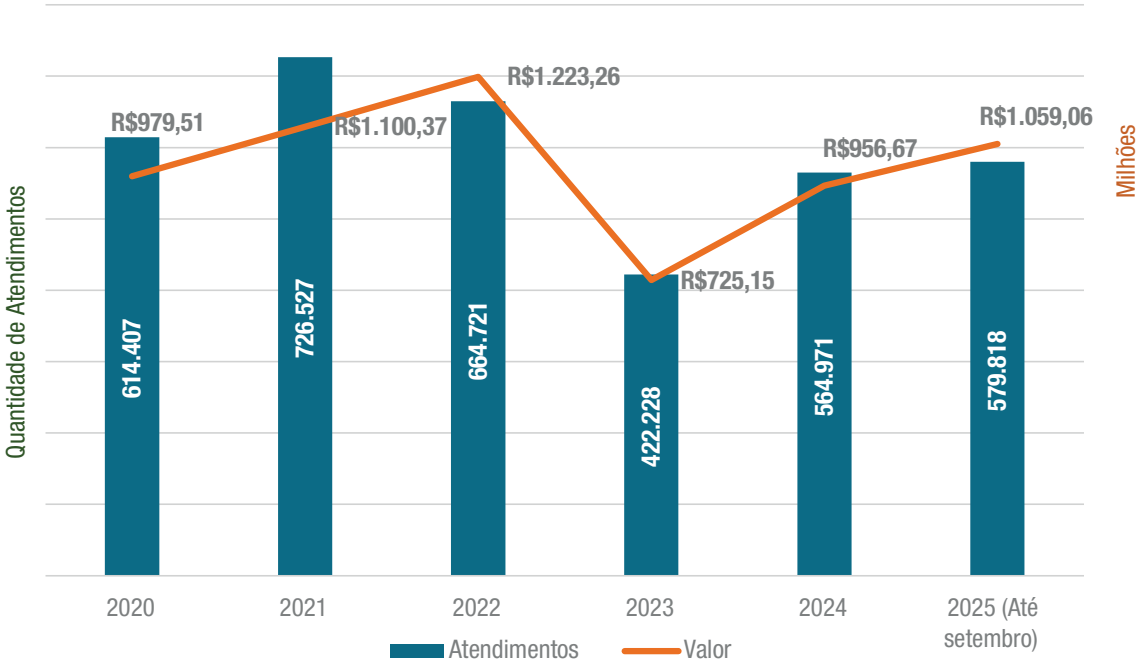
Gráfico 10 - Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade registrados em APAC ocorridos no SUS e em beneficiários de planos de saúde – atendimentos de 2020 a setembro de 2024.



Fonte: MS/Datasus e ANS/SGR (novembro/2025).
Nota: O gráfico exibe o ano dos atendimentos ocorridos no SUS, cuja notificação no âmbito do Ressarcimento ao SUS ocorre cerca de 1 ano depois. Resultados passíveis de atualização.
Nota 2: São incluídos na cobrança de ressarcimento ao SUS os procedimentos ambulatoriais registrados em APACs nos grupos 02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica; 03 – Procedimentos Clínicos; 04 – Procedimentos Cirúrgicos; 05 – Transplantes de órgãos; e 07 - Órteses, próteses e materiais especiais.

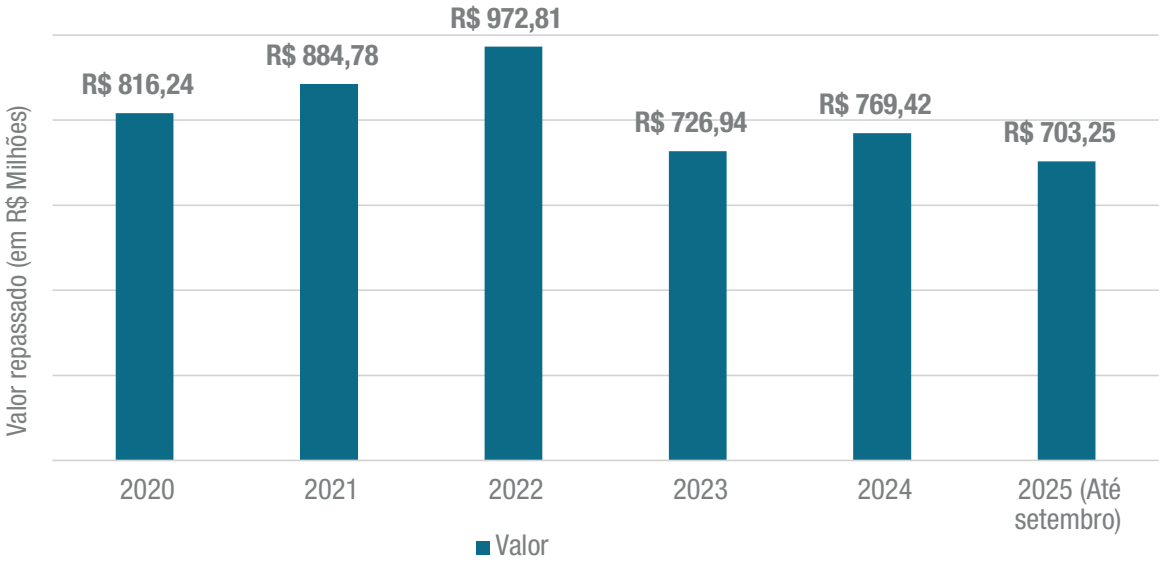
Quanto aos valores de atendimentos no âmbito do processo de Ressarcimento ao SUS, incluindo AIHs e APACs, foram cobrados até setembro de 2025 R$ 1,05 bilhões e repassados no mesmo período R$ 703 milhões ao FNS (gráficos 11 e 12). Esta condição está associada a eventuais variações na utilização do SUS por beneficiários, no lançamento regular de Avisos de Beneficiários Identificados (ABIs), no passivo de análises de impugnações e recursos no bojo do Processo Administrativo de Ressarcimento ao SUS, no procedimento de inscrição em Dívida Ativa, nas atividades de saneamento processual e de cobrança, com impactos sobre o resultado do Repasse ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Gráfico 11 - Atendimentos e valores cobrados no Ressarcimento ao SUS – Brasil (2020 a setembro de 2025).



Fonte: SGR/ANS (novembro/2025).
Nota: O gráfico exibe o ano de cobrança dos atendimentos ocorridos no SUS, podendo abranger casos ocorridos em competências variadas, a depender do andamento dos processos administrativos. Resultados passíveis de atualização.

Gráfico 12 - Valor anual repassado ao Fundo Nacional de Saúde (em R$ Milhões) – Brasil (2020 a 2025).



Fonte: SGR/ANS (novembro/2025).
Nota: O gráfico exibe o ano de repasse dos valores cobrados e pagos dos atendimentos ocorrido no SUS, podendo abranger casos ocorridos em competências variadas, a depender do andamento dos processos administrativos. Resultados passíveis de atualização.

No portal da ANS, é possível consultar outros dados e publicações sobre o Ressarcimento ao SUS na área: Dados e Indicadores do setor > Dados e Publicações do Ressarcimento ao

SUS. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/dados-e-publicacoes-do-ressarcimento-ao-sus.

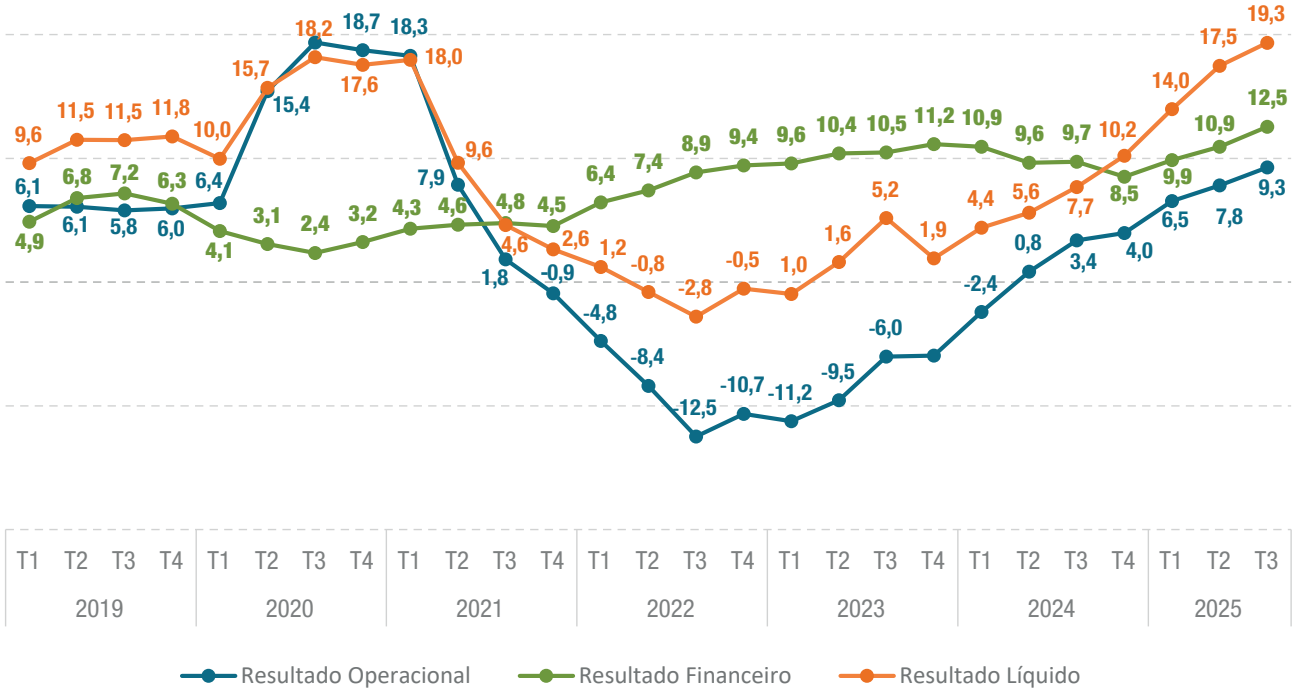
4 CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Evolução dos resultados

O foco desta seção é o comportamento dos indicadores de resultado do setor de saúde suplementar na operação médico-hospitalar. Tais indicadores são apresentados em valores nominais (não ajustados pela inflação do período) ao longo dos últimos quatro anos, segregados entre resultado operacional, resultado financeiro e resultado líquido (gráfico 11).

No 3º trimestre de 2025, o setor continua em seu viés de alta, renovando as máximas desde 2019, com exceção do período pandêmico, tanto no resultado líquido quanto no resultado operacional. O resultado líquido acumulado nos últimos quatro trimestres atingiu R$ 14 bilhões, (gráfico 13), completando 8 trimestres consecutivos de resultados positivos neste recorte.

Gráfico 13 - Resultados, Operadoras Médico-Hospitalares, Acumulado em 12 meses (em R$ bilhões).



Fonte: ANS/DIOPS e Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar
Nota: Os resultados referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres são aproximações com base no efeito dos impostos e participações do exercício anterior. A apuração efetiva dessas contas geralmente se dá ao final do ano, portanto, seu efeito real nos últimos 12 meses é conhecido apenas no 4º trimestre de cada ano.

Também o resultado financeiro segue apresentando melhoras em relação ao trimestre anterior, atingindo R$ 12,5 bilhões, em seu terceiro trimestre consecutivo de alta.

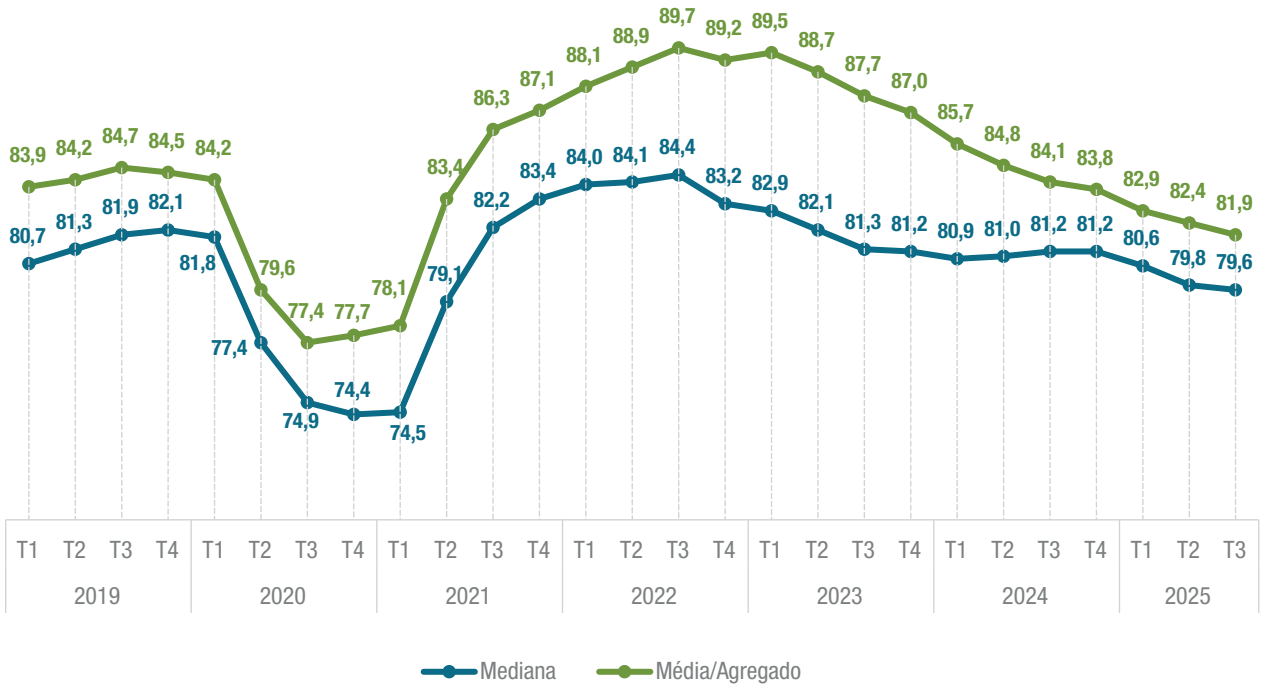
Sinistralidade

A sinistralidade é um dos indicadores mais relevantes na operação de planos de saúde e representa, grosso modo, a porcentagem das receitas com contraprestações (mensalidades) pagas pelos contratantes, que é consumida com o pagamento de eventos indenizáveis (despesas assistenciais). A sinistralidade do setor é apresentada aqui através da média agregada e da mediana deste indicador entre as operadoras de planos de saúde.

A análise da mediana permite limitar a influência de valores extremos na análise, enquanto a média é mais impactada pelas operadoras com maior volume de beneficiários.

A mediana da sinistralidade (gráfico 14) mostrou ligeira queda de 0,2 p.p. em relação à medição anterior, mantendo a tendência notada ao longo do ano de 2025, enquanto a sinistralidade agregada continua em tendência mais acentuada de queda, com diminuição de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e 2,2 p.p. quando comparada ao mesmo período do ano anterior, novamente inferior aos patamares pré-pandêmicos do indicador para o trimestre.

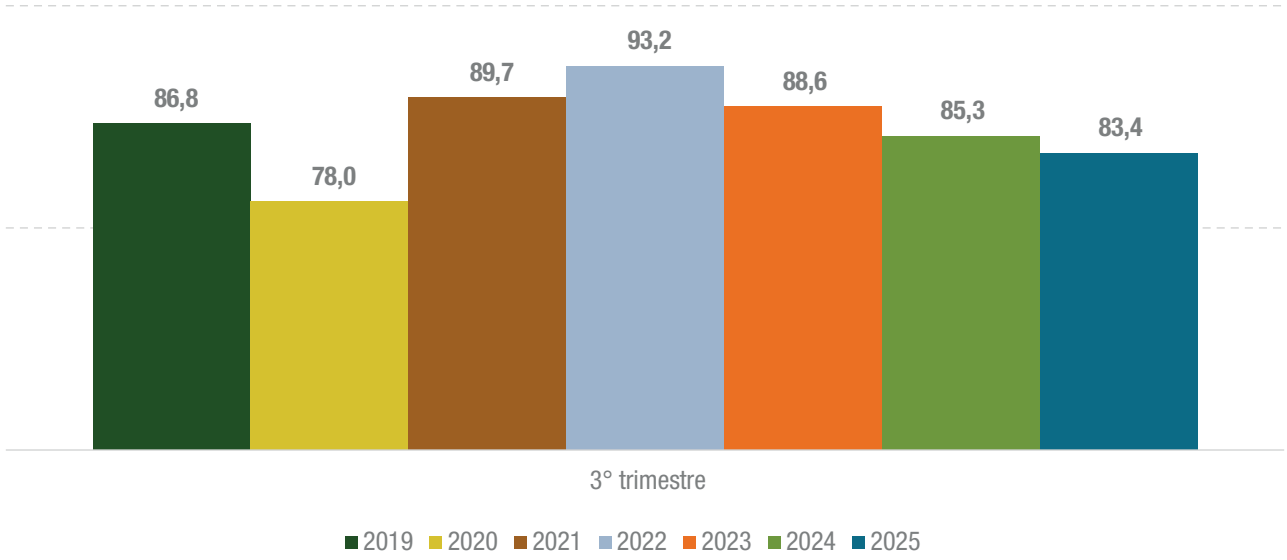
Gráfico 14 - Sinistralidade Média e Mediana (%)
Operadoras médico-hospitalares, acumulado em 12 meses.



Fonte: ANS/DIOPS e Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar

O gráfico 15 mostra a evolução da sinistralidade média nos terceiros trimestres de cada ano, desde 2019. Essa comparação oferece visão mais imediata do comportamento da sinistralidade e isola a sazonalidade presente na operação de planos de saúde. Este indicador também denota queda em relação ao ano anterior – 0,9 p.p., e encontra-se no mínimo da série histórica, com exceção do observado durante a pandemia.

Gráfico 15 - Sinistralidade média no trimestre (%) Operadoras médico-hospitalares.

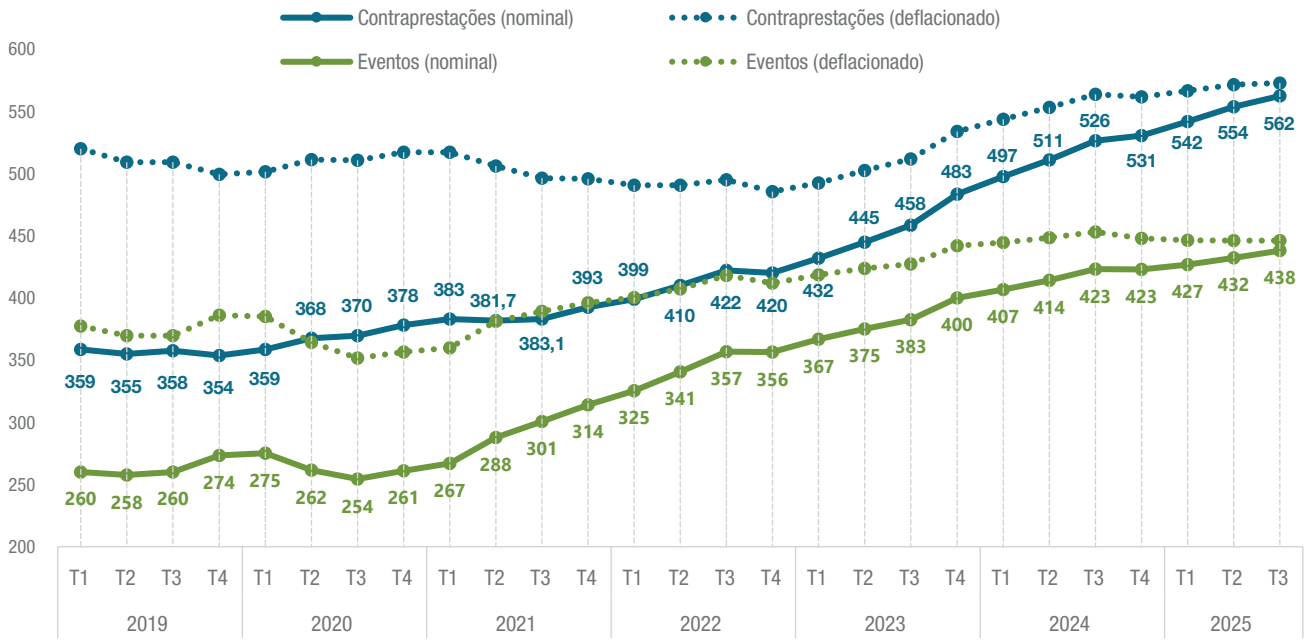


Fonte: ANS/DIOPS e Painel Contábil da Saúde Suplementar.

Receitas e Despesas Assistenciais

O gráfico 16 apresenta a evolução trimestral das contraprestações (receitas assistenciais) e eventos (despesas assistenciais) per capita acumulados em 12 meses, em valores nominais e em valores reais (descontada a inflação). Esses índices compõem o indicador de sinistralidade, sendo importante analisá-los separadamente para compreender sua evolução.

Gráfico 16 - Contraprestações e Eventos (Despesa Assistencial) per capita, valores nominais e deflacionados (R$/mês) Planos médico-hospitalares, acumulado em 12 meses.



Fonte : ANS/DIOPS, ANS/SIB, SIDRA/IBGE

Notas: Total de contraprestações e eventos dos últimos 12 meses, exceto tributos diretos e variações de provisões técnicas, dividido pela soma de beneficiários nos últimos 12 meses. Valores deflacionados correspondem a valores nominais, descontada a inflação medida pelo IPCA. Apenas planos com formação de preço preestabelecida.

A relação entre os valores nominais de receitas e despesas, apresentadas no gráfico 16, define o patamar de sinistralidade apresentado nos gráficos anteriores. Em termos nominais, no último período analisado a receita per capita atingiu R$ 562 por mês, continuando a tendência de aumento neste valor. Já a despesa per capita apresentou ligeiro aumento, alcançando o valor mensal de R$ 438.

Ao expurgar o efeito da inflação nestas séries históricas verifica-se comportamento diverso entre a receita, com leve alta no trimestre e a despesa, estável.

5 INFORMAÇÕES DE DEMANDAS DO CONSUMIDOR

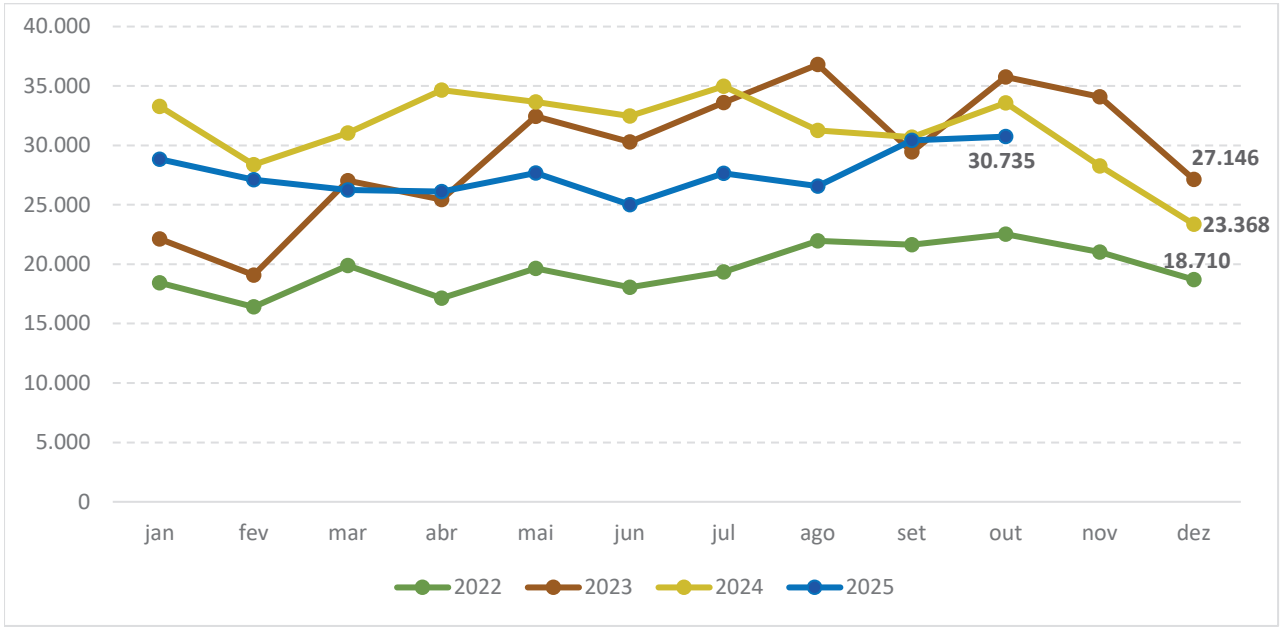
As informações apresentadas nesta seção referem-se ao acompanhamento mensal das reclamações registradas junto aos canais de atendimento da ANS.

São itens de destaque: a evolução das reclamações NIP, a avaliação por natureza das reclamações (assistenciais e não assistenciais), o Índice Geral de Reclamações (IGR) e a Taxa de Intermediação Resolvida (TIR) e as Ações Planejadas de Fiscalização.

Evolução das reclamações NIP

O gráfico 17 apresenta a evolução das reclamações tratadas por meio na Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), tanto as demandas de natureza assistencial quanto as de natureza não assistencial. Observa-se que, nos meses de janeiro a outubro de 2025, as reclamações NIP cadastradas na ANS apresentaram redução em relação ao mesmo período de 2024 e, também, em relação aos meses de março, maio, junho, julho, agosto e outubro de 2023, indicando uma tendência de redução neste indicador.

Gráfico 17 - Evolução de reclamações NIP (assistencial e não assistencial).

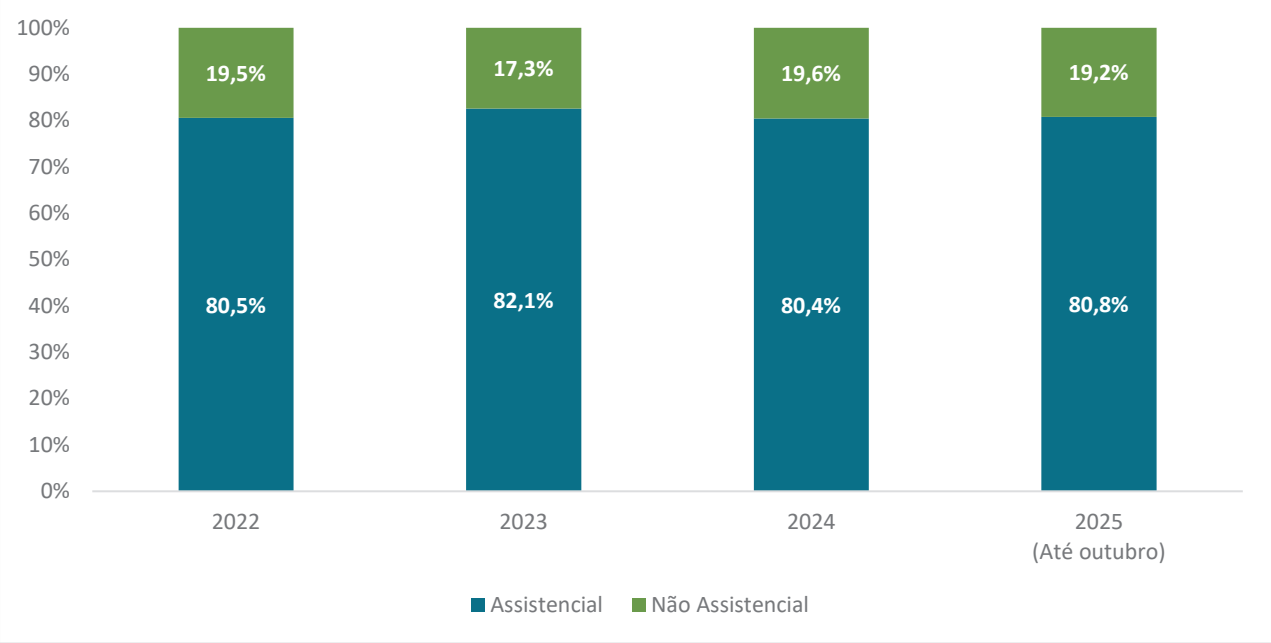


Fonte: Painéis de Fiscalização (ANS) (jan. 2022 a out.2025).

Natureza das demandas

As demandas de natureza assistencial, ou seja, aquelas relacionadas a toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial, representaram 80,8%, do total de reclamações NIP cadastradas entre janeiro e outubro 2025, mantendo a preponderância em relação às demandas de natureza não assistencial (gráfico 18).

Gráfico 18 - Distribuição percentual de reclamações NIP por natureza das demandas.



Fonte: Painéis de Fiscalização (ANS) (jan. 2022 a out. 2025).

Índice Geral de Reclamações (IGR)

O Índice Geral de Reclamações (IGR) é uma métrica calculada pela ANS com base nas reclamações registadas por consumidores e que foram processadas via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP). Seu cálculo considera a relação entre a média de reclamações registadas por consumidores, em determinado período contra operadoras de planos de saúde registadas na ANS, e a média do número de beneficiários dessas operadoras, no mesmo período.

O resultado obtido indica uma relação inversamente proporcional à satisfação dos beneficiários. Ou seja, quanto menor o valor do IGR, maior é a satisfação dos beneficiários com as operadoras.

Importante destacar que o IGR não é calculado para as administradoras de benefícios, pois ainda não possuem informações sobre o total de vidas administradas (beneficiários) junto ao Sistema de Informação de Beneficiários (SIB-ANS), o que impossibilita o cálculo do IGR.

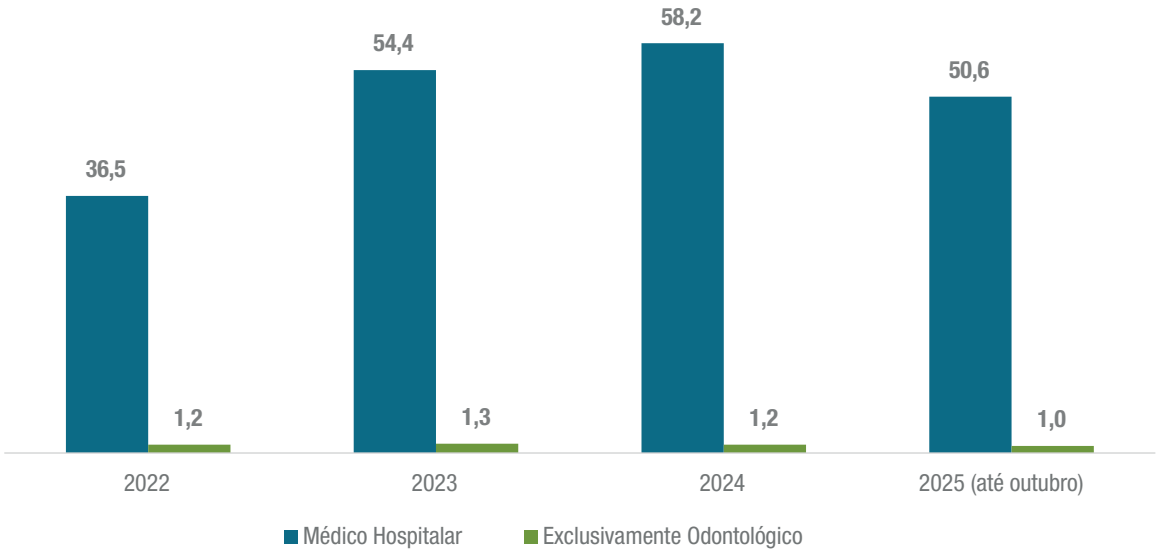
Este é um importante indicador utilizado pela ANS. Pelo Painel IGR é possível verificar, por exemplo, a evolução de reclamações registradas na ANS com possibilidade de consulta por

período de tempo, porte de operadora ou, ainda, a evolução de uma operadora específica. Assim, é possível comparar o índice de uma operadora com a média nacional ou com o grupo de operadoras do mesmo porte, e verificar se aquela operadora está abaixo, acima ou dentro da média.

O gráfico 19 mostra que os planos de assistência médico hospitalar tiveram no ano de 2024 a média de 58,2 reclamações para cada 100 mil beneficiários, enquanto tal média nos meses de janeiro a outubro de 2025 foi de 50,6, reclamações para cada 100 mil beneficiário. Por sua vez, os planos exclusivamente odontológicos tiveram em média 1,0, reclamação para a mesma quantidade de beneficiários no período de janeiro a outubro de 2025 e de 1,2 para cada 100 mil beneficiários, em 2024.

Os resultados observados no gráfico 19 indicam uma melhora nos resultados do IGR das operadoras de planos de saúde e de planos de cobertura exclusivamente odontológica em 2025 (até outubro), em relação ao ano anterior, indicando um crescimento da satisfação do consumidor, mas, ainda acima do resultado de 2022 para os planos de assistência médico hospitalar.

Gráfico 19 - Índice Geral de Reclamações (IGR) por 100 mil beneficiários, por cobertura assistencial.



Fonte: Painéis de Fiscalização (ANS) (jan. 2022 a outubro. 2025).

Taxa de Intermediação Resolvida (TIR)

A Taxa de Intermediação Resolvida (TIR) é uma métrica calculada pela ANS com base nas reclamações registradas por consumidores e que foram processadas via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP). A TIR permite avaliar a capacidade de resolução consensual de conflitos entre beneficiários e operadoras de planos de saúde e/ou administradoras de benefícios, por meio de mediação da ANS, ainda na fase eletrônica (seja a demanda de natureza assistencial ou não assistencial), sem necessidade de abertura de processo

administrativo sancionador. Seus resultados são apresentados em formato de Painel Dinâmico, no site da ANS[2], atualizados mensalmente.

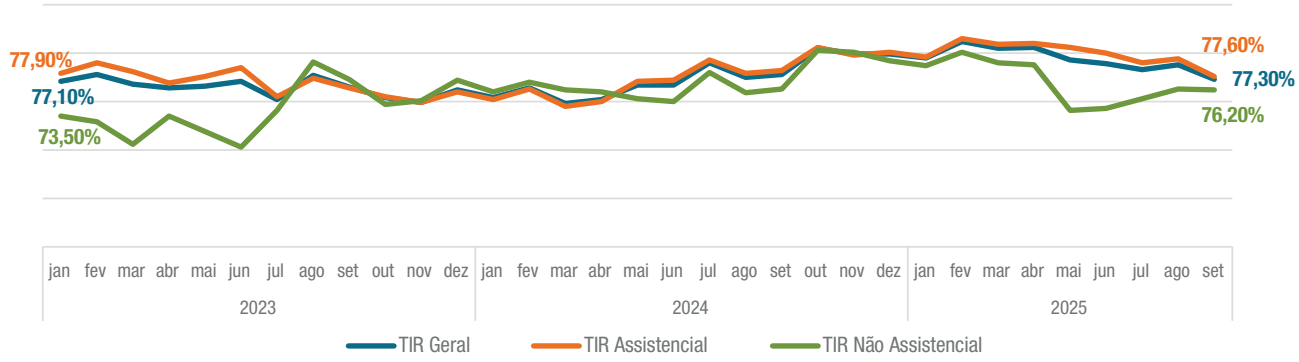
Esta taxa reflete a perspectiva dos consumidores em relação à solução de suas demandas logo após a fase de mediação, apresentando a proporção daquelas consideradas resolvidas na visão do consumidor[3], em relação ao total de demandas NIP cadastradas no período analisado.

Tal indicador tem por finalidade dar mais transparência às informações sobre as queixas registradas por consumidores junto aos canais de relacionamento da ANS, possibilitando à sociedade saber de que forma as operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios se comportam diante dessas demandas/reclamações.

Até o lançamento desta ferramenta, a Agência utilizava como parâmetro a Taxa de Resolutividade (TR), que avaliava a demanda após o término do prazo concedido à operadora e após a análise do caso por um dos analistas da NIP.

Em 2024, a Taxa de Intermediação Resolvida (TIR), da mediação de conflitos feita pela ANS por meio da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), alcançou índice médio de 77,4%. Em 2025 (até o mês de setembro), a TIR atingiu índice médio de 79,4%. Este dado refere-se ao conjunto das reclamações cadastradas na ANS, no período, e que foram passíveis de mediação (gráfico 20).

Gráfico 20 - Taxa de Intermediação Resolvida - TIR (Demandas NIP Assistenciais e Não Assistenciais).



Fonte: Painéis de Fiscalização (ANS) (de jan. 2023 a set. 2025).

Ações de Fiscalização Planejada

As Ações de Fiscalização Planejada (AFPs) correspondem a um conjunto de ações fiscalizatórias de natureza sistematizada, de escalonamento gradativo, com fundamento em princípios da regulação responsiva, que visam a estimular as operadoras de planos privados de assistência à saúde ao exercício da autorregulação ou ao equacionamento de questões e

2 TIR- Dados e Indicadores do Setor - Painéis de Fiscalização (ANS)

3 Isto é, demandas inativas com retorno do consumidor, informando que seu problema foi resolvido, bem como demandas inativadas por ausência de resposta do consumidor (presunção de resolução).

processos internos, para o aprimoramento dos serviços prestados aos consumidores. Nesse sentido, as Operadoras são monitoradas e enquadradas em uma das modalidades das AFPs a partir de seu desempenho em índices estabelecidos pela ANS, em especial o Índice Geral de Reclamações (IGR), que pode ser acessado através do site da Agência.

Desde o segundo semestre de 2023, foram realizadas diligências no âmbito de 2 ações fiscalizatórias: Ação Planejada Focal de Fiscalização (APF) e Ação Planejada Preventiva de Fiscalização (APP), conforme ilustra a tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Ações de Fiscalização Planejada, 2023 a 2025

2023	APF (Projeto-Piloto)	11 operadoras e 2 administradoras de benefícios, com a realização de 32 diligências na forma remota e 4 na modalidade in loco
2024	APF	7 operadoras e 2 administradoras de benefícios, tendo sido realizadas 32 diligências remotas e 1 diligência in loco
	APP	5 operadoras e 1 administradora de benefícios, com 6 diligências remotas
2025	APF	4 operadoras, com 8 diligências na forma remota
	APP	3 operadoras e 3 diligências na forma remota. Outras 3 operadoras foram selecionadas para ações ainda em 2025, e encontram-se fase de definição dos assuntos para tratamento pelas operadoras selecionadas.

Fonte: processos SEI/ANS.

Os processos do Projeto-Piloto da APF (2023) foram encerrados na sua quase totalidade, com a verificação de melhora na entrada de reclamações à ANS em 6 operadoras. Embora 4 operadoras não tenham apresentado melhora substancial no registro de demandas de consumidor até o final do período de monitoramento, para duas delas foi verificada redução do IGR durante o ano de 2025. Ainda no ano de 2025, 2 das operadoras tiveram sua liquidação extrajudicial decretada pela ANS, em razão de graves anormalidades econômico-financeiras, enquanto uma teve o seu registro cancelado por incorporação societária.

Das operadoras e administradoras de benefícios selecionadas para a APF/2024, 5 apresentaram redução nas demandas e, para 4, ainda não tinham sido verificada melhora substancial no IGR.

Na APP/2024, 5 das 6 operadoras participantes apresentaram melhora no IGR, até o fim do período de monitoramento. Em 2025, uma dessas operadoras experimentou grande aumento no IGR em razão da alienação da quase totalidade da sua carteira, como estratégia de negócios.

Os processos administrativos das operadoras da APF/2025 e da APP/2025 ainda se encontram em curso, em estágios variados do fluxo da respectiva ação planejada. Os resultados serão apresentados ao fim do período de monitoramento, em relação ao registro de demandas de consumidor à ANS.

Todas as operadoras permanecem em monitoramento até que os seus processos administrativos sejam arquivados.

Em relação às operadoras que comercializam produtos exclusivamente odontológicos, atualmente, não há nenhuma selecionada para as Ações de Fiscalização Planejada (APF), tendo em vista que, por apresentarem valores de IGR muito abaixo dos das operadoras da segmentação médico-hospitalar.

Cumpre ressaltar que a Diretoria de Fiscalização faz o monitoramento destes dados, que são utilizados para o planejamento e adoção de ações, tanto de caráter punitivo, quando indutivo de boas práticas pelas operadoras de planos de saúde. E, ainda, estes dados são subsídios para a reformulação das ações e estratégias fiscalizatórias no âmbito da revisão normativa em curso na Diretoria de Fiscalização da ANS.

6 PROGRAMAS E PROJETOS DA ANS

Com a publicação da Medida Provisória (MP) nº 1.301 de 30 de maio de 2025, da Portaria GM/MS nº 7.266 de 18 de junho de 2025 e da Portaria Conjunta MS/AGU Nº 7.702 de 28 de julho de 2025, o Ressarcimento ao SUS passa a fazer parte do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. Ainda em outubro de 2025, a MP foi convertida na Lei nº 15233/2025: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-15.233-de-7-de-outubro-de-2025-661016471>.

Destaca-se como objetivo do programa a ampliação do acesso da população a consultas, exames e procedimentos especiais, contribuindo para a redução dos tempos de espera em filas. Nesse cenário, foi instituído o componente Ressarcimento ao SUS (figura 2), a partir do qual se pretende aproveitar os recursos devidos, transformando dívidas das operadoras em serviços de saúde, por meio de assinatura de termo de compromisso e execução dos serviços aprovados pelos gestores do SUS nas regiões propostas.

A participação das operadoras de planos privados de saúde na prestação de serviços prioritários ao SUS, mediante adesão voluntária e sem a necessidade de aportes financeiros extras por nenhuma das partes, vislumbra a geração de retorno imediato para a população, além de fortalecer a responsabilidade das operadoras junto ao sistema de saúde brasileiro.

Figura 2 – Componentes do Programa Agora tem Especialistas



Fonte: Site do Ministério da Saúde (link: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/agora-tem-especialistas)

É importante ressaltar a corresponsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no que diz respeito ao acompanhamento do cumprimento dos termos de execução, bem como em relação ao monitoramento de eventuais impactos da adesão ao programa sobre a prestação da assistência aos beneficiários das operadoras participantes, e ao comportamento dessas empresas quanto à identificação de casos e o pagamento dos processos rotineiros de Ressarcimento ao SUS, que continuarão ocorrendo.

Finalmente, vale apontar a contribuição do programa neste componente para a geração de oportunidade no que se refere à integração de dados em saúde no país, uma vez que os atendimentos prestados no bojo do novo programa serão registrados não apenas em Autorizações de Internação Hospitalares (AIH) e Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) - para redes que já possuem contratualização com o SUS -, mas também por meio do Conjunto Mínimo de Dados (CMD) - para aqueles hospitais que nunca atenderam ao SUS. Assim, colabora-se para a composição da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma do Ministério da Saúde para conectar e integrar o sistema de saúde de todo o Brasil, com vistas à interoperabilidade de dados, troca segura e padronizada de informações entre o setor público e privado, promovendo uma visão unificada do histórico de saúde do cidadão, melhorando a gestão, a eficiência e a qualidade do atendimento.

No Portal do Ministério da Saúde, estão disponibilizados textos explicativos e links para a legislação específica do Programa Agora Tem Especialistas, navegue em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/agora-tem-especialistas.

7 ASPECTOS NORMATIVOS E LEGAIS

Alterações no marco legal da Saúde Suplementar (Lei 9.656/1998)

Lei nº 15.171/2025

Em 17 de julho de 2025, foi publicada a Lei nº 15.171, que altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, e a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para ampliar o direito das mulheres à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação total ou parcial.

A alteração na Lei dos Planos de Saúde ocorre no Art. 10-A, referente à cobertura de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, com a seguinte redação:

> Art. 10-A. Cabe à operadora definida no inciso II do caput do art. 1º desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação total ou parcial do órgão.
>
> § 1º Em caso de mutilação decorrente de tratamento cirúrgico, será utilizada, salvo contraindicação médica, a técnica cirúrgica de reconstrução simultânea ou imediata da mama, realizada em continuidade à intervenção cirúrgica que provocou a mutilação, respeitada a autonomia da mulher para, plenamente esclarecida, decidir livremente pela execução do procedimento.
>
> .... " (NR) (Brasil, 2025).

Lei nº 15.233/2025

Em 7 de outubro de 2025, foi publicada a Lei nº 15.233, que institui o **Programa Agora Tem Especialistas**; dispõe sobre o Grupo Hospitalar Conceição S.A.; e altera algumas leis, incluindo a Lei nº 9.656/1998.

Esta Lei é resultado da Conversão da Medida Provisória nº 1.301, de 2025, que foi divulgada na edição anterior do Panorama Saúde Suplementar.

O Ministério da Saúde (MS) está conduzindo o planejamento para implementação do Programa. No que tange à saúde suplementar, a regulamentação específica ocorreu a partir da publicação de Portarias Conjuntas entre o MS e a Advocacia-Geral da União (AGU):

- **Portaria Conjunta MS/AGU nº 7.266, de 18/06/2025**: Dispõe sobre o Programa Agora Tem Especialistas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A seção V, arts. 11 e 12, tratam especificamente do Componente Ressarcimento ao SUS; e
- **Portaria Conjunta MS/AGU nº 7.702, de 28/07/2025**: Dispõe sobre a regulamentação do Componente Ressarcimento do Programa "Agora Tem Especialistas".

Arcabouço normativo

Nos meses junho a novembro de 2025, foram publicados dezoito novos normativos, sendo onze Resoluções Normativas (RN) referentes a alterações no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS: RN nº 635; 637; 642; 643; 645; 646; 647; 648; 650; 651 e 652.

As RNs nº 638 e 641 alteraram a RN nº 623, de 17/12/2024, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde e Administradoras de Benefícios nas solicitações de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários, bem como não assistenciais, em qualquer modalidade de contratação.

Os demais normativos publicados no período referem-se, especificamente:

- RN nº 636, de 24/06/2025: Dispõe sobre a transmissão dos arquivos, entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e a ANS, das bases da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) e dos Comunicados de Reajustes de Planos Coletivos (RPC), por meio do Programa Transmissor de Arquivos – PTA;
- RN nº 639, de 07/07/2025: Revoga a RN ANS nº 551, de 11/11/2022, e desobriga as operadoras do envio do SIP a partir de 02/03/2026;
- RN nº 640, de 16/07/2025: Altera a RN nº 574, de 28/02/2023, que dispõe sobre os critérios de constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;
- RN nº 644, de 30/09/2025: Altera a RN nº 506, de 30/03/2022, que institui o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde;
- RN nº 649, de 04/11/2025: Altera a RN ANS nº 137, de 14/11/2006 e revoga a Instrução Normativa nº 20, de 29/04/2022, ambos referentes às entidades de autogestão na saúde suplementar. A norma entrará em vigor em 01/07/2026.

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

De julho até novembro de 2025[4], 8 novas Resoluções Normativas com atualização do Rol foram publicadas, e 11 novas tecnologias foram incorporadas (tabela 2).

Além das novas tecnologias incorporadas, houve atualização da Diretriz de Utilização referente à imunoprofilaxia para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

4 Dados até 28/11/2025.

Tabela 2 - Tecnologias incorporadas ao Rol de procedimentos da ANS, por grupo, 2022- 2025*

Grupo	2022	2023	2024 (1ºt)	2024 (2ºt)	2024 (3ºt)	2024 (4º t)	2025 (1º t)	2025 (2ºt)	2025 (3ºt)	2025 (4ªt)
Terapia Antineoplásica Oral	19	8	-	2	2	3	1	-	-	2
Terapia Imunobiológica e Outras Terapias Para Infusão	9	12	1	2	6	3	2	3	2	1
Testes Diagnósticos (Laboratoriais e de Imagem)	7	3	1	2	-	3	1	1	-	3
Procedimentos	6	7	1	5	3	1	1	-	2	1
Total	41	30	3	11	11	10	5	4	4	7

Fonte: GGRAS/DIPRO/ANS (2025).
*Notas:
Tomando por base a data de publicação das RNs e não a vigência da cobertura.
Dados até 28/11/2025.
As atualizações do 2º tri de 2025 se devem a incorporações realizadas após a data de corte da publicação anterior (16/06).

Monitoramento da participação social na produção normativa

A participação social na ANS ocorreu por meio de audiências públicas e consultas públicas sobre os normativos em elaboração. No 2º e 3º trimestres, foram realizadas seis Audiências Públicas (AP) e nove Consultas Públicas (CP) foram encerradas no mesmo período.

O processo de elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde representou a maioria dos mecanismos de participação realizados. Os demais temas abordados foram:

- Aprimoramento das regras relacionadas às Autogestões;
- Política de Preços e Reajustes; e
- Visita técnico-assistencial para identificação de anormalidades assistenciais nas operadoras de planos de assistência à saúde.

O quadro 1, a seguir, ilustra os temas das normas e o número de contribuições em cada Consulta Pública (CP), encerradas entre abril e setembro de 2025, além de trazer informações sobre as Audiências Públicas (AP) realizadas no período.

Quadro 1 – Participação social, por tema e quantidade de contribuições (CPs) / número de participantes (APs), encerradas entre abril e setembro de 2025.

Tipo	Descrição	Data	Nº Contribuições CP ou Informações AP	Link
CP	CP nº 153: Proposta de Resolução Normativa que busca o aprimoramento das regras relacionadas às Autogestões.	10/04/2025 a 26/05/2025	238	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/153
CP	CP nº 154: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	09/04/2025 a 28/04/2025	1011	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/154
CP	CP nº 155: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	15/05/2025 a 03/06/2025	9844	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/155
CP	CP nº 156: Proposta de Resolução Normativa que altera a IN DIPRO nº 53, de 2017, que regulamenta a visita técnico-assistencial para identificação de anormalidades assistenciais nas operadoras de planos de assistência à saúde.	22/05/2025 a 06/07/2025	37	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/157
CP	CP nº 157: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	12/06/2025 a 03/07/2025	714	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/157
CP	CP nº 158: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	10/07/2025 a 29/07/2025	9844	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/158
CP	CP nº 159: Nova participação social com vistas a ampliar o debate público em torno da efetiva implementação da Política de Preços e Reajustes dos Planos de Saúde	21/07/2025 a 19/10/2025	1577	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/159
CP	CP nº 160: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	13/08/2025 a 01/09/2025	3941	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/160

CP	CP nº 161: contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.	10/09/2025 a 29/09/2025	275	https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/161
AP	AP nº 54: contribuições acerca de recomendação preliminar de não incorporação para as seguintes tecnologias (Tildrakizumabe e Pirtobrutinibe).	16/04/2025, das 09:30 às 12:30	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencias-publicas-realizadas-1/audiencia-publica-54
AP	AP nº 55: contribuições acerca de recomendação preliminar de não incorporação para as seguintes tecnologias: (i) UAT 154 Anifrolumabe para Tratamento de pacientes com lupus eritematoso sistêmico (LES) com moderada a alta atividade e falha à terapia tripla com hidroxicloroquina + corticosteroide + imunossupressor e (ii) UAT 159 - Selpercatinibe para Tratamento de pacientes adultos e pediátricos com carcinoma medular de tireoide avançado ou metastático RET positivo (RET+).	21/05/2025, das 9h30 às 12h30	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencias-publicas-realizadas-1/audiencia-publica-no-55

AP	AP nº 56: contribuições em relação à recomendação preliminar desfavorável das tecnologias: (i) UAT 152 - Teste pré-natal não invasivo (NIPT) para detecção de aneuploidias fetais específicas, como trissomia 21 (síndrome de Down), trissomia 18 (síndrome de Edwards) e trissomia 13 (síndrome de Patau), por meio da análise de DNA fetal circulante no sangue materno em gestantes de alto risco; (ii) UAT 153 - Mepolizumabe em combinação com corticosteroide intranasal no tratamento de pacientes adultos (≥ 18 anos) com rinossinusite crônica com pólipos nasais grave, contagem de eosinófilos ≥ 300 células/µL e histórico de cirurgia, que não obtiveram controle adequado da doença com uso da terapia padrão; e (iii) UAT 165 - Lenalidomida em combinação com Tafasitamabe, seguida de monoterapia com Tafasitamabe, para o tratamento de pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) recidivante ou refratário, incluindo LDGCB decorrente de linfoma de baixo grau, e que não são elegíveis para transplante autólogo de células-tronco (ASCT).	27/06/2025, das 09:00 às 13:00	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencias-publicas-realizadas-1/audiencia-publica-no-56
AP	AP nº 57: contribuições em relação à recomendação preliminar desfavorável das tecnologias: (i) UAT 158 – Fremanezumabe no tratamento preventivo de enxaqueca em adultos com pelo menos 4 dias de enxaqueca por mês, refratários a três tratamentos prévios e (ii) UAT 163 – Belimumabe no tratamento adjuvante de pacientes adultos ((≥ 18 anos) com lúpus eritematoso sistêmico (LES) e alto grau de atividade da doença apesar do uso da terapia padrão	18/07/2025, das 09:30 às 12:30	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencias-publicas-realizadas-1/audiencia-publica-no-57

AP	AP nº 58: contribuições acerca de recomendação preliminar de não incorporação para as seguintes tecnologias: (i) UAT 160 - Implante de válvula aórtica transcateter (TAVI) no tratamento da estenose valvar aórtica grave para pacientes com risco cirúrgico baixo (escore STS-PROM <4%) como primeira linha de tratamento; e (ii) UAT 166 - Dupilumabe no tratamento complementar de pacientes adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) associada à inflamação tipo 2 (caracterizada por meio de contagem de eosinófilos no sangue maior ou igual a 300 células/mm3), em uso de terapia tripla inalatória (antimuscarínico de longa ação (LAMA) + ß2-agonista de longa ação (LABA) + corticoides inalatórios (CI)) e com perfil exacerbador.	28/08/2025, das 14h às 17h.	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencia-publica-no-58
AP	AP nº 59: contribuições em relação à recomendação preliminar desfavorável das tecnologias: (i) UAT 168 - Balão intragástrico para tratamento de adultos com obesidade graus I e II (IMC igual ou maior que 30 e menor que 40 Kg/m2), sem sucesso na perda de peso após intervenções convencionais e (ii) UAT 173 - Cloridrato de alectinibe para tratamento adjuvante de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) de estágio IB (tumores =4 cm) até IIIA após ressecção do tumor que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK).	19/09/2025, das 9h30 às 12h30.	Microsoft Teams	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/audiencias-publicas/audiencias-publicas-realizadas-1/audiencia-publica-no-59

Fonte: GPLAN/SECEX/PRESI/ANS (2025).

PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTROS ESCLARECIMENTOS, ENTRE EM CONTATO COM A ANS. VEJA ABAIXO NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

Disque ANS
0800 701 9656

Atendimento Eletrônico
www.gov.br/ans

Atendimento presencial em Núcleos da ANS
Acesse o portal e confira os endereços

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos
0800 021 2105

ans.reguladora @ANS_reguladora company/ans_reguladora @ans.reguladora ansreguladoraoficial

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO